

Anexo A Plantilla de priorización MoSCoW

Equipo: Cedeño Wilson, Morales Gary, Sánchez Gary **Paralelo:** B **Fecha:** 03/06/2026

Escriba **M** (Must), **S** (Should), **C** (Could) o **W** (Won't) en cada celda. Las columnas Cliente y Desarrollador son la priorización individual (Fase 2); la columna Consenso es el resultado negociado (Fase 5).

ID	Requisito (resumen)	Esf.	Cliente	Desarroll.	Consenso
RF-01	Registro de pacientes	3	M	M	M
RF-02	Reserva de citas en línea	5	M	M	M
RF-03	Consulta por videollamada	8	M	C	M
RF-04	Pago en línea (tarjeta)	8	M	W	W
RF-05	Receta electrónica firmada	5	S	W	W
RF-06	Historial clínico digital	5	S	C	C
RF-07	Recordatorios de cita	3	S	S	S
RF-08	Panel del médico (agenda)	5	M	M	M
RF-09	Calificación del médico	3	M	C	S
RF-10	Chat asíncrono	5	S	W	W
RF-11	Facturación electrónica	5	S	W	W
RF-12	Reportes de actividad	5	M	C	C
NFR-01	Cifrado / protección de datos	5	S	C	M
NFR-02	Usabilidad (adultos mayores)	3	C	S	M
NFR-03	Latencia videollamada <250 ms	3	S	C	C
NFR-04	Disponibilidad 99,5 %	5	S	C	C
Suma de esfuerzo de los Must (consenso):		29 pts (debe ser ≤ 30)			

La nota “analista” no se prioriza por separado: el analista no marca su propia columna porque no defiende intereses; su trabajo se evalúa por la calidad de la mediación y del acta. (El analista así verifica que la columna “Consenso” respete capacidad y dependencias.)

Anexo B Votación ponderada (desempate)

Use esta tabla solo para los requisitos que el equipo dejó en disputa (“Should” que compiten por la capacidad restante). Califique cada criterio de 1 a 5 y multiplique por su peso. El de mayor puntaje total entra primero.

Criterios y pesos: Valor de negocio (0,40) · Bajo esfuerzo (0,25) · Bajo riesgo técnico (0,20) · Urgencia/dependencia satisfecha (0,15).

ID	Requisito en disputa	V. negocio (x0,40)	Bajo esf. (x0,25)	Bajo riesgo (x0,20)	Urgencia (x0,15)
RF-07	Recordatorios de citas	$5 * 0.40 = 2.00$	$5 * 0.25 = 1.25$	$5 * 0.20 = 1.00$	$5 * 0.15 = 0.75$
RF-09	Calificación del médico	$3 * 0.40 = 1.20$	$5 * 0.25 = 1.25$	$5 * 0.20 = 1.00$	$3 * 0.15 = 0.45$

ID	Puntaje total ponderado (suma de los cuatro productos)	Orden
RF-07	$2.00 + 1.25 + 1.00 + 0.75 = 5.00$	1
RF-09	$1.20 + 1.25 + 1.00 + 0.45 = 3.90$	2

Anexo C Acta de negociación

C.1 Conflictos identificados

Registre al menos **dos** conflictos surgidos durante la negociación.

N°	Descripción del conflicto	Tipo / causa	Roles implicados
1	La clienta quiere videollamada y pago en línea.	Conflicto de intereses.	Cliente, desarrollador líder y analista de requisitos.
2	La clienta quiere receta electrónica.	Conflicto estructural por dependencia técnica.	Cliente, desarrollador líder y analista de requisitos.

C.2 Resolución win-win

Explique, para **cada** conflicto, qué acuerdo alcanzaron y por qué ambas partes ganan (no por imposición). Indique qué se cedió y qué se obtuvo a cambio.

Conflicto 1:

Se acordó incluir la videollamada en la primera versión y dejar el pago en línea para la segunda versión. La clienta obtiene una función atractiva para los pacientes y el desarrollo reduce riesgos técnicos.

Conflicto 2:

Se decidió posponer la receta electrónica hasta que estén listas las condiciones técnicas y normativas. La clínica lanza la primera una versión funcional y el equipo evita incumplir dependencias.

C.3 Verificación del analista

Marque con ✓ cuando se cumpla.

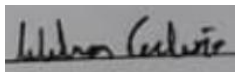
- ✓ La suma del esfuerzo de los Musí es ≤ 30 puntos.
- ✓ Todo requisito Musí tiene sus dependencias marcadas como Musí.
- ✓ Si se aceptó pago en línea (RF-04), receta electrónica (RF-05) o historial clínico (RF-06), el cifrado (NFR-01) es Musí.
- ✓ RF-11 (facturación) no es Musí mientras REST-01 no esté disponible.
- ✓ Cada categoría (M/S/C/W) tiene al menos un requisito (la lista no es solo "Must").

C.4 Reflexión final (mínimo 120 palabras)

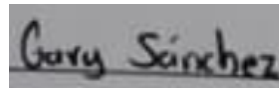
¿Qué estrategia de resolución de conflictos predominó y por qué? ¿Qué habría pasado si la dueña de la clínica hubiera impuesto todas sus prioridades sin negociar?

La estrategia de resolución de conflictos que predominó en este caso fue la negociación colaborativa con enfoque win-win, ya que se buscó alcanzar acuerdos que beneficiaran tanto a la clínica como al equipo de desarrollo. Durante la priorización surgieron diferencias entre los requisitos que aportaban mayor valor al negocio y aquellos que eran técnicamente viables dentro de la capacidad disponible para el Release 1. Después de analizar el esfuerzo, las dependencias y las restricciones del proyecto, se decidió priorizar las funcionalidades esenciales para ofrecer una plataforma útil desde el primer lanzamiento. Esta decisión permitió mantener el esfuerzo total dentro del límite establecido y garantizar una entrega realista.

Además, se respetaron los requisitos de seguridad y usabilidad necesarios para manejar información médica sensible. Gracias a este proceso, se logró un equilibrio entre las necesidades de los usuarios, los objetivos de la clínica y las posibilidades técnicas del equipo, reduciendo riesgos y aumentando las probabilidades de éxito del proyecto.



Firma – Cliente

Firma – Analista

Firma - Desarrollador